SDD 14 Sujet n°1

Spécialité : Médecine d'urgence/réanimation

Date : 09/10/2023
Auteur : LACAMPAGNE Thomas (DES en Médecine Intensive et Réanimation, Bordeaux)
Relecteur(s) : ELAYLI Robin (DES Psychiatrie Grenoble, ECN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie pertinente de la prise en charge
Domaine d'apprentissage secondaire	Urgence vitale
Item(s) en lien avec la station	ITEM 205 Hémoptysie ITEM 359 Détresse respiratoire aigue ITEM 309 tumeur broncho-pulmonaire
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 14 : émission de sang par la bouche
Matériel nécessaire à la station	
Contexte de la station	

ECOS TACFA

INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne aux urgences de votre CHU et vous recevez M.TOUSTOUS, 56 ans. Ce dernier se présente car il tousse du sang depuis ce matin. Il se dit également gêné pour respirer.

ANTÉCÉDENTS :
- bronchectasies sur des infections respiratoires récidivantes.
- tabagisme à 40 paquets/année.
- FA persistante

TRAITEMENTS : anti-vitamine K et anti-arythmique

EXAMENS PARA-CLINIQUE RÉCENTS :
- scanner, il y a 1 an, avec bronchectasies sans autre anomalie.
- EFR sans anomalie ventilatoire

Une radiographie thoracique et un ECG sont réalisés et reviennent normaux (en dehors de la fibrillation atriale connue à l'ECG). Le bilan sanguin est en cours.

Un scanner thoracique injecté a été réalisé.

Constantes : TA à 167/86 mmHg, FC à 106 bpm, Sp02 en AA à 92%, FR à 28 cycles/min, apyrétique, dextro à 1,15 g/L. Le patient est scopé en continu.

Consignes :
Vous devez en 8 minutes :
- Demander un examen sanguin à l'IDE au lit du patient
- Demander l'examen d'imagerie le plus adapté et le décrire
- Proposer une prise en charge thérapeutique de ce patient

Vous ne devez pas :
- Interpréter l'imagerie

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)		
1.	Demande une gazométrie artérielle	1 pt
2.	Énonce une alcalose respiratoire	1 pt
3.	Énonce un patient normoxémique et alactique	1 pt
4.	Demande la mise en place d'un traitement vasoconstricteur par terlipressine	1 pt
5.	Demande à initier le traitement en IV	1 pt
6.	Demande un scanner injecté thoracique	1 pt
7.	Dit vouloir contacter les réanimateurs du fait de la détresse respiratoire pour la surveillance	1 pt
8.	Énonce contacter les radiologues interventionnels pour évoquer l'artério-embolisation	1 pt
9.	Antagonise les AVK par 10 mg de vitamine K et PPSB	1 pt
10.	Demande de prévoir un contrôle INR à 30 minutes avec cible < 1,5	1 pt
11.	Demande la pose de 2 VVP	1 pt
12.	Demande à l'IDE la mise en place d'une oxygénothérapie 15 L/min	1 pt
13.	Précise l'oxygénothérapie par masque haute concentration	1 pt

Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)

6. COMMUNICATION AVEC LES PAIRS (clarté de communication)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de communiquer le message	Est capable de communiquer les principaux messages, n'arrive pas à les justifier	Est capable de communiquer les principaux messages et justifier son raisonnement	Communique les informations pertinentes et les justifie. Ne s'attarde pas à de l'information inutile	Relie les informations provenant des domaines différents faisant preuve d'une maîtrise du sujet

7. APTITUDE À COOPÉRER avec les pairs

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Autoritaire / Difficulté à coopérer	Communique. Transmet l'information	Communique. Adopte la technique de reformulation.	Communique les renseignements pertinents. Reconnaît les obstacles à la communication. Délègue les responsabilités en respectant les autres.	Reconnaît les problèmes de communication et sait les régler avec adresse.

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL (max 14 items)	**X points**

<u>Gaz du sang sous 15L d'Oxygène :</u>

- pH : 7,49
- pC02 : 30 mmHg

- p02 : 99 mmHg
- HCO3- : 23 mmHg
- Lactates : 0,8 mmol/L

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Le/La candidat.e doit prendre en charge une hémoptysie chez un patient porteur de bronchectasie.

Plan de la station ECOS :

Le patient simulé est allongé et vous êtes à côté de lui

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

C'est bon j'ai envoyé un bilan standard. L'ECG et la radio sont normaux apparemment, qu'est ce que tu veux qu'on fasse pour ce patient ?

Identité du patient :

Monsieur TOUSTOUS, 56 ans

Antécédents personnels :

Bronchectasies sur des infections récidivantes sans trouble ventilatoire à l'EFR avec dernier scanner il y a un an retrouvant des bronchectasies sans autre anomalie. FA sous anticoagulant et anti-arythmique.

Médicaments :

Antivitaminique K Anti-arythmique

Constantes :

TA à 167/86 mmHg, FC à 106 bpm, Sp02 en AA à 92%, FR à 28 cycles/min, apyrétique, dextro à 1,15 g/L

Questions de relance :

- Si le candidat ne propose pas un gaz du sang après 3 minutes d'ECOS, lui dire "tu voudrais pas que je lui fasse un autre prélèvement sanguin" - Si le candidat n'antagonise pas après 4 minutes d'ECOS, lui dire "oh mais le patient crache encore du sang, je me demande si c'est pas à cause des anti-coagulants" - Si le candidat n'appelle pas les réanimateurs après 6 min d'ECOS, lui dire "moi je pense pas qu'on puisse garder ce patient aux urgences" - Si le candidat n'initie aucun traitement après 5 min d'ECOS, lui dire "il n'y a pas un médicament qu'on pourrait mettre ou alors venir boucher le vaisseau qui saigne"